의료진 진료 카드 · ASL-052

임신 준비 · 갑상선 기능에 따른 분기

TSH 상승이 있으면 임신 시기 조율과 TPO 항체 평가를 함께 한다.

임신 전 TSH 목표: 0.5~2.5 mIU/L



본강의 · 준비 단계의 관리

TSH 상승	강의는 임신을 미루고 기능을 평가·조절한 뒤 진행하는 흐름으로 제시했다. 불임·ART 예정 등 빨리 임신해야 하는 사정을 치료 결정에 반영했다.
정상 기능·TPO 양성	본강의는 LT4 치료를 권장하지 않고 TSH를 3~6개월마다 모니터링하도록 제시했다.

연자 Q&A · 반복 유산이 있는 별도 상황

임신 준비 + TPO(+)	반복 유산 과거력이 있고 TSH 2.5~4 mIU/L인 경우 치료를 고려할 수도 있다는 답변이다.
적용 구분	정상 기능 항체 양성자 전체에 치료를 확대하지 않는다. 위 상황은 반복 유산과 임신 준비 조건을 붙인 연자 Q&A 의견으로 읽는다.

본강의 · 조절과 임신 예후

조절되지 않은 저하증	유산·임신성 고혈압·조산·자녀 발달 위험을 설명했다.
생화학적으로 잘 조절	기존 갑상선기능저하증도 잘 조절하면 임신 합병증과 소아 발달 예후는 정상 임신과 대등하다는 메시지다. 임신 중 T4/T3 병용은 금기로 설명했다.

참고범위, 치료 시작 기준, 치료 목표를 구분한다. 본강의의 정상 기능·항체 양성 비치료와 Q&A의 반복 유산 예외 의견은 각각 해당 대상에 적용한다.

의료진 진료 카드 · ASL-052

임신 중 새로 발견한 기능이상

검사 시약과 분기, fT4·TSH 조합으로 나눈다.

현성 저하증과 SCH의 치료 시작 분기

현성 저하증
TSH ≥6: LT4 시작
<6: mild overt
1~3주 내 재검 고려

SCH · 1분기
TSH >10: LT4 시작
4~10: 치료 고려
4~6: 1~3주 재검 가능

SCH · 2~3분기
새로 진단된 4~10
치료 없이 4~6주 추적
TSH 상승 시 치료

본강의 · 임신 검사 해석

TSH 참고범위	분기별·기관별 참고치를 우선 적용. 자체 기준이 없으면 1~2분기 TSH 0.1~4.0 mIU/L를 제시했다.
TT4 보정	fT4가 애매하면 total T4를 활용한다. 7~16주는 비임신 상한 대비 매주 5% 증가, 16주 이후는 상한 대비 50% 증가로 보정한다.

본강의 · fT4가 살짝 낮을 때

Mild overt	임신 중 assay 영향으로 fT4가 낮게 나올 수 있다. TSH <6 mIU/L인 mild overt는 1~3주 내 재검을 고려하는 분기로 소개했다.
2~3분기 경증 SCH	1분기 정상범위였다가 2~3분기에 새로 발견된 TSH 4~10 mIU/L는 즉시 치료 대신 4~6주 후 추적한다는 Q&A 보완 설명이다.

연자 Q&A · 참고치와 치료 목표

참고범위 상한	기관 기준이 없을 때 TSH 4 mIU/L를 기준으로 한다.
LT4를 시작·복용 중	정상 범위 안에서 가능하면 TSH <2.5 mIU/L로 조절한다는 본강의와 Q&A 설명. 강의 요약 목표는 0.5~2.5 mIU/L이다.

신규 SCH의 TSH >10 치료 분기는 교재 도표를 따른다. 임신 1분기의 4~10 치료 고려와 2~3분기 새 경증 SCH의 관찰 분기를 구분해 적용한다.

의료진 진료 카드 · ASL-052

기존 LT4 복용자 · 임신부터 산후까지

임신 중 증량과 분만 후 감량·중단 시도를 구분한다.

시기별 검사와 용량 재평가



본강의 · 임신 확인 즉시

기존 복용자	빨리 내원해 갑상선기능검사를 시행하고 약 25% 증량을 고려한다. 예: 매일 1정 주 7회 → 주 9회(주말에 2정씩).
추적과 목표	20주까지 약 4주 간격, 이후 최소 1회(보통 30주 전후) TSH를 본다. 목표는 정상 범위 안에서 가능하면 <2.5 mIU/L.

본강의 · 분만 직후의 두 경로

임신 전부터 LT4	분만 직후 임신 전 용량으로 감량. 산후 6주 TSH·fT4로 적정성 재평가. 출산 후 체중이 많이 남으면 감량한 용량이 부족해 재조정할 수 있다.
임신 중 SCH로 신규 시작	분만 직후 약물 중단 시도를 고려. 산후 6주 중단 상태의 TSH로 재개 여부를 평가한다. 기존 영구적 저하증의 일괄 중단과 구분한다.

본강의 · 복약과 산후 요오드

복약	아침 식전 60분, 대안은 식후 최소 3시간 공복 뒤 취침 전. 칼슘·철분 등은 4시간 간격. 검사일은 채혈 후 LT4를 복용한다.
요오드	갑상선이 남아 있는 산모는 과도한 미역국·요오드 섭취를 피하도록 설명했다. 연자는 미역국 주 1회로도 충분한 섭취가 된다는 예를 들었다.

산후 중단 시도는 임신 중 SCH로 새로 치료한 환자의 경로다. 기존 LT4 복용자는 임신 전 용량 복귀와 산후 재검을 연결한다.